

傷口止血包紮

(一)若傷口持續出血時，應直接以無菌紗布放置於出血處，施以直接加壓止血，並以彈性繃帶或三角巾等適當敷料包紮持續加壓；若仍繼續出血，絕不要移除原有紗布及敷料，應在其上方加上更多紗布直接加壓，並再次以彈性繃帶或三角巾等適當敷料加壓包紮。若上述方法仍無法有效止血且有生命危險或傷口為可見大出血預期無法有效止血時，儘早使用外傷用止血帶。

(二)若傷口無持續出血時，可用以生理食鹽水浸濕無菌紗布，濕敷於傷口處，以膠帶固定紗布，必要時以網套、彈性繃帶或三角巾等適當敷料加強固定。

註：濕敷的紗布以微濕擠不出水為原則。

(三)傷口填塞

操作步驟：

1. 評估暴露：移除(必要時剪開)覆蓋傷口的衣物。
2. 指壓止血：用手指纏繞適當傷口填塞紗布往傷口最深處塞入，探查時應注意可能有骨折或玻璃碎片等尖銳物在患處內。
3. 深層填塞：持續使用傷口填塞紗布朝向傷患「出血處(如可辨識)」或近心端，持續塞入。
4. 緊密填實：持續將傷口填塞紗布塞入，直到整個傷口空腔被填滿、塞實；傷口填塞紗布應高於傷口表面 1-2 吋，以利壓力有效傳遞。
5. 垂直加壓：填滿後，用雙手掌心垂直向下全力加壓。
6. 包紮維壓：若出血停止或傷患仍有其他大出血的傷口，維持傷口填塞紗布位置，用繃帶或三角巾加壓包紮。

注意事項：

1. 頸部(側面頸部可操作，填塞時應注意是否會影響呼吸道；靠近氣管處不可執行)、胸腔、腹腔、背部及頭部不可深層填塞，僅能進行表面填塞；若 EMT 可辨識出傷口未進入顱骨內、胸腔或腹腔內時，可考慮進行填塞。
2. 不可移除異物：若傷口內異物穿刺附著，不可拔除，應固定異物並壓迫其周邊。
3. 填塞過程傷患會極度疼痛，應持續給予傷患心理支持，直到完成填塞並持續施壓；必要時 EMT 可給予傷患止痛。